



EXAMEN BLANC DE RESIDANAT

année universitaire 2025-2026

Epreuve 2 (B)
98 QCM et 18 cas cliniques
22 Octobre 2025

Cette épreuve comprend 98 QCM et 18 cas cliniques

Partie A : QCM

Veillez inscrire les réponses aux QCM dans la grille réservée aux QCM

QCM 1- Les complications de l'hypothyroïdie périphérique sont :

- A- Un syndrome cérébelleux
- B- Un épanchement péricardique
- C- Des hallucinations auditives
- D- Un syndrome d'apnée du sommeil
- E- Elargissement de la différentielle

QCM 2- Une altération de la fonction ventilatoire au cours de l'hypothyroïdie est secondaire à :

- A- Une myopathie musculaire respiratoire
- B- Une macroglossie
- C- Un renforcement de la force contractile du myocarde
- D- Une augmentation de l'apport d'oxygène au myocarde
- E- Un épanchement pleural

QCM 3- Les causes d'hypothyroïdie iatrogène sont :

- A- Le Sélénium
- B- Inhibiteurs de la tyrosine kinase
- C- Le thyrozol ®
- D- Le cynomel®
- E- L'Amiodarone

QCM 4- Le dosage de TSH à réaliser en cas suspicion d'hypothyroïdie :

- A- Doit être complété par FT3
- B- Doit être de première intention
- C- Doit être à jeun
- D- Est freinée dans la forme primaire
- E- Peut être normal dans la forme centrale

QCM 5- Les causes iatrogènes d'hyperthyroïdie sont :

- A- Les inhibiteurs de tyrosine kinase
- B- Le lugol avant thyroïdectomie
- C- La corticothérapie
- D- Le lithium
- E- L'amiodarone

QCM 6- Les facteurs déclenchants potentiels de crise aiguë thyrotoxique sont :

- A- La phase précoce du traitement par iode radioactif
- B- Un Accident vasculaire cérébral
- C- L'hémisuccinate d'hydrocortisone en IV
- D- L'administration de produit de contraste iodé
- E- L'instauration d'anti-thyroïdiens de synthèse

QCM 7- L'ophtalmopathie basedowienne :

- A- Est améliorée par les anti-thyroïdiens de synthèse
- B- Est sans relation avec le degré de thyrotoxicose
- C- Est en relation avec le taux des anticorps anti-récepteurs de TSH
- D- A une origine auto-immune
- E- Peut-être aggravée par un traitement par iode radioactif

QCM 8- L'ophtalmopathie basedowienne peut être aggravée par :

- A- La chirurgie thyroïdienne
- B- Une élévation de TSH
- C- La corticothérapie en IV
- D- Le tabac
- E- Le sélénium

QCM 9- Les causes de maladie d'Addison sont:

- A- Un surdosage en AVK
- B- La tuberculose
- C- Le traumatisme abdominal grave
- D- Radiothérapie cérébrale
- E- Les anticorps anti-21hydroxylase

QCM 10- Une insuffisance surrénalienne associée à des surrénales hypertrophiées peut être observée au cours de :

- A- Une mutation du gène Prop1
- B- La tuberculose
- C- Un cancer du sein
- D- Un bloc enzymatique en 21 hydroxylase
- E- Une Apoplexie hypophysaire récente

QCM 11- Une insuffisance surrénalienne aiguë chez un patient infecté par VIH peut être due à une atteinte surrénalienne par:

- A- Le Kétoconazole
- B- L'hémisuccinate d'hydrocortisone
- C- La tuberculose
- D- Le traitement anti-rétroviral
- E- Une localisation surrénalienne de sarcome de Kaposi

QCM 12- L'insuffisance surrénalienne aiguë au cours de la maladie d'Addison se distingue d'une IS centrale par :

- A- Une ACTH freinée
- B- La sévérité du tableau clinique
- C- L'absence de déficit en minéralocorticoïde
- D- Une tendance à l'hyperkaliémie
- E- La pâleur

QCM 13- Les causes possibles d'une insuffisance surrénale périphérique aiguë sont:

- A- Un syndrome des anticorps anti-phospholipides
- B- Une apoplexie hypophysaire
- C- Un surdosage aux anticoagulants
- D- Un traumatisme crânien grave
- E- Méningococcie

QCM 14-Le caractère malin d'une adénopathie est suspecté devant les caractéristiques suivantes :

- A- Le caractère mal limité de l'adénopathie
- B- Le caractère douloureux
- C- Le caractère inflammatoire
- D- La consistance ferme
- E-La consistance dure

QCM 15-Le bilan de 1ère intention à demander devant une adénopathie superficielle comprend

- A-TDM à la recherche d'adénopathies profondes
- B- LDH
- C- Bilan hépatique
- D- Calcémie
- E- Sérologie VIH

QCM 16-Devant des polyadénopathies, la brucellose est évoquée devant :

- A-Une hyperleucocytose
- B- Un contage alimentaire
- C- Une fièvre prolongée hectique
- D- Une lymphopénie
- E- Une éosinophilie

QCM 17-Devant des polyadénopathies, la sarcoidose est évoquée devant

- A- Une anergie à la tuberculine
- B- Une enzyme de conversion est élevée
- C- Une hypercalciurie
- D- Le caractère compressif des adénopathies
- E- Le caractère douloureux des adénopathies

QCM18- Le coma est défini comme :

- A- Une altération transitoire de la vigilance
- B- Une abolition durable de la conscience et de la vigilance
- C- Un Glasgow inférieur ou égal à 15
- D- Un état réversible par la stimulation douloureuse
- E-Une abolition de la conscience associée à une absence d'éveil spontané ou provoqué

QCM 19- Un patient comateux présente des pupilles intermédiaires aréactives, une paralysie de la verticalité du regard et un Babinski bilatéral. Où se situe la lésion ?

- A- Cortex frontal bilatéral
- B- Mésencéphale
- C- Protubérance
- D- Bulbe
- E- Diencephale

QCM 20- Un myosis punctiforme bilatéral évoque :

- A- Une atteinte protubérantielle
- B- Une atteinte mésencéphalique
- C- Une atteinte diencephalique
- D- Une intoxication opiacée
- E- Une encéphalopathie post-anoxique

QCM 21- La dyslipidémie la moins fréquente est la dyslipidémie

- A- secondaire
- B- de type IIa hétérozygote
- C- de type IIb
- D- de type IV
- E- de type I

QCM 22- Dans la plaque vasculaire, les LDL sont plus athérogènes s'ils sont :

- A- oxydés
- B- estérifiés
- C- de densité élevée
- D- de grande taille
- E- reconnus par leur LDL récepteur

QCM 23- Les triglycérides en excès se déposent dans :

- A- le pancréas
- B- le foie
- C- les paupières
- D- la rate
- E- les parois vasculaires

QCM 24- L'exploration d'une anomalie lipidique comporte :

- A- le dosage des triglycérides
- B- le calcul du LDL-cholestérol
- C- le dosage du cholestérol total
- D- le calcul du non HDL-cholestérol
- E- le dosage du HDL-cholestérol

QCM 25-Parmi les critères définissant le syndrome métabolique on retient l'élévation :

- A- du HDL-cholestérol
- B- du LDL-cholestérol
- C- de la glycémie
- D- de la pression artérielle
- E- de l'IMC (Indice du Masse Corporelle)

QCM 26-Le risque vasculaire est élevé en cas d' excès de:

- A- chylomicrons
- B- HDL
- C- IDL
- D- VLDL
- E- LDL

QCM 27-Une hyperlipoprotéïnémie peut être secondaire à:

- A- un éthylisme chronique
- B- une stéatose hépatique
- C- un syndrome de cushing
- D- un syndrome néphrotique
- E- une insuffisance surrénalienne

QCM 28-Les critères hémodynamiques typiques d'un état de choc cardiogénique sont :

- A. Index cardiaque $< 2,2 \text{ L/min/m}^2$
- B. Pression Artérielle Pulmonaire d'Occlusion (PAPO) $> 15 \text{ mmHg}$
- C. pression veineuse centrale $< 2 \text{ mmHg}$
- D. Pression artérielle diastolique $< 40 \text{ mmHg}$
- E. Lactatémie $> 2 \text{ mmol/L}$

QCM 29-La contractilité myocardique :

- A. Diminue lors d'une acidose
- B. Dépend des récepteurs bêta-adrénergiques
- C. Est majorée par le parasymphatique
- D. Dépend de l'état des protéines contractiles
- E. Est indépendante de l'oxygénation myocardique

QCM 30-Le traitement étiologique du choc cardiogénique comporte :

- A. le drainage péricardique en cas de tamponnade
- B. la chirurgie cardiaque en cas de thrombose de prothèse valvulaire
- C. un traitement anti-arythmique en cas de trouble du rythme sévère
- D. une greffe cardiaque immédiate en cas de myocardite fulminante

E. un antidote par bicarbonate molaire IV en cas d'une intoxication par les tricycliques

QCM 31- Le risque infectieux après une fracture ouverte de jambe est plus important en cas de :

- A- Diabète déséquilibré
- B- Délabrement important des parties molles
- C- Mécanisme par écrasement
- D- Ouverture cutanée Cauchoux I
- E- Traitement chirurgical par plaque vissée

QCM 32-Le diagnostic de pseudarthrose septique de la jambe repose sur :

- A- Douleurs à la mise en charge
- B- Mobilité du foyer de fracture
- C- Présence d'une fistule
- D- Condensation des berges fracturaires
- E- Déficit des releveurs du pied

QCM 33-La prise en charge thérapeutique d'une fracture de jambe type III selon la classification de Cauchoux, est :

- A- Un enclouage centromédullaire
- B- Une amputation en cas d'atteinte artérielle réparable
- C- Une ostéosynthèse par plaque vissée
- D- Une fixation externe
- E- Une couverture de la perte de substance par un lambeau en urgence si l'os est exposé

QCM 34-Après traitement d'une fracture de jambe, lors de la première phase de rééducation :

- A- L'appui total est non autorisé au patient
- B- A pour objectif la récupération des amplitudes articulaires
- C- Le renforcement musculaire à l'aide d'appareil est autorisé
- D- A pour durée quinze jours
- E- L'utilisation de canne est obligatoire

QCM 35- Parmi les conditions suivantes, celles qui peuvent cadrer avec une pseudarthrose aseptique de la jambe:

- A- le tabagisme actif est un facteur favorisant.
- B- l'histoire d'un écoulement purulent de la cicatrice opératoire est en faveur ce diagnostic.
- C- peut se traduire radiologiquement par une cassure du matériel d'ostéosynthèse.
- D- peut se traduire par une mobilité du foyer fracturaire.
- E- le siège proximal de la fracture est un facteur favorisant

QCM 36-Devant une hématurie associée à une douleur lombaire on évoque :

- A- Une cystite
- B- Une sténose de l'artère rénale
- C- Une lithiase rénale
- D- Une tumeur rénale
- E- Une glomérulonéphrite post infectieuse

QCM 37- Devant une hématurie associée à un complément sérique bas on évoque :

- A- Une glomérulonéphrite avec dépôts mésangiaux d'immunoglobuline A
- B- Une cryoglobulinémie
- C- Une vascularite à ANCA
- D- Un syndrome hémolytique et urémique atypique
- E- Un syndrome d'Alport

QCM 38- La glomérulonéphrite aiguë post infectieuse est :

- A- Récidivante
- B- Fréquente chez le sujet âgé
- C- Traitée par des antibiotiques
- D- Révélée le plus souvent par un syndrome néphritique aigu
- E- Classiquement bénigne

QCM 39-Les mécanismes suivants sont impliqués dans le développement d'une splénomégalie

- A- Surcharge pondérale
- B- Augmentation de la pression dans le système porte
- C- Hyperplasie splénique
- D- Prolifération lymphoïde
- E- Métaplasie myéloïde

QCM 40- Quelles sont les propositions exactes relatives à la technique d'examen de la rate?

- A- En demandant au malade de faire une apnée en inspiration profonde
- B- Est palpée sur un malade en décubitus latéral droit
- C- Avec le bout des doigts sous les côtes gauches
- D- L'examineur se place du côté gauche du malade
- E- Est palpée sur un malade en décubitus dorsal

QCM 41- La suspicion d'une anémie hémolytique devant une splénomégalie implique de demander :

- A- Le TP
- B- Les réticulocytes
- C- Les LDH
- E- La bilirubine directe
- D- La ferritinémie

QCM 42- Les valeurs normales de la calcémie totale en mmol/l sont :

- A- Entre 1,2 et 1,6mmol/l
- B- Entre 2,1 et 2,5 mmol/l
- C- Entre 2,2 et 2,6 mmol/l
- D- Entre 2,3 et 2,8mmol/l
- E- Entre 3,2 et 3,6mmol/l

QCM 43- La parathormone (PTH) est une hormone qui:

- A- Stimule directement les ostéoblastes
- B- Diminue l'excrétion urinaire du phosphore
- C- Augmente la réabsorption urinaire du calcium
- D- Augmente directement l'absorption digestive du calcium
- E- Est régulée par le taux du calcium plasmatique

QCM 44- Les signes fonctionnels d'une hypercalcémie peuvent être :

- A- Des réflexes ostéo-tendineux abolis
- B- Un syndrome sub-occlusif
- C- Des crampes musculaires
- D- Une hypertension artérielle
- E- Des douleurs osseuses

QCM 45- Une hypercalcémie peut être secondaire à:

- A- Une hémochromatose
- B- Une sarcoïdose
- C- Une chondrocalcinose
- D- Un myélome multiple
- E- Une maladie de Hodgkin

QCM 46- L'athyréose chez le nourrisson :

- A. entraîne un tableau grave dès la naissance
- B. est la cause la plus fréquente de dysgénésie thyroïdienne
- C. se présente avec des hormones thyroïdiennes indétectables

D. se présente avec une TSH très élevée

E. est responsable d'une diminution de la thyroglobuline dans le sang

QCM 47- Le retard diagnostique d'une hypothyroïdie chez le nourrisson expose à (aux) risque(s) suivants :

A. avance staturale

B. complications cardiovasculaires

C. retard mental irréversible

D. un nanisme harmonieux

E. obésité contrastant avec un retard statural

QCM 48- Les dysgénésies thyroïdiennes incluent :

A. les défauts de migration de l'ébauche thyroïdienne

B. les mutations inactivatrices des récepteurs thyroïdiens

C. les hypoplasies thyroïdiennes

D. les anomalies du développement thyroïdien

E. l'absence totale du tissu thyroïdien

QCM 49 : Les signes cliniques suivants font évoquer un ictère à bilirubine conjuguée chez l'enfant:

A- Selles décolorées

B- Erythrose palmaire

C- Urines foncées

D- Prurit

E- Angiomes stellaires

QCM 50 : Dans l'atrésie des voies biliaires :

A- l'ictère est à bilirubine conjuguée

B- les selles sont normocolorées

C- les ASAT et les ALAT sont élevées

D- les voies biliaires intra-hépatiques sont dilatées à l'échographie

E- les GGT sont normales

QCM 51-La syphilis secondaire :

A- La première floraison survient dans les 6 semaines suivant le chancre

B- Se caractérise par des lésions vésiculeuses touchant les paumes et les plantes

C- Survient dans 50% des cas après une syphilis primaire non traitée

D- Les lésions cutanées sont toujours contagieuses

E- Se caractérise sur le plan sérologique par un TPHA - et VDRL +

QCM 52-Le gonocoque :

A- Est un germe strictement intracellulaire

B- Se transmet de la mère à l'enfant au cours de l'accouchement

C- Se manifeste par des ulcérations génitales chez la femme et une urétrite aiguë chez l'homme

- D- Peut être responsable d'une atteinte anorectale asymptomatique
- E- Les fluoroquinolones représentent le traitement de choix

QCM 53-L'infection à herpès simplex virus (HSV) :

- A-Est un co- facteur important de l'infection par le VIH
- B- Se caractérise par une primo-infection symptomatique dans 90 % des cas
- C- Elle survient au début de l'activité sexuelle
- D- Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- E- La latence est cliniquement silencieuse et s'effectue dans les ganglions nerveux sensitifs

QCM 54-La variabilité génétique du VIH :

- A-Est à l'origine de la résistance du virus au traitement antirétroviral
- B- Est due aux erreurs commises par l'intégrase lors de l'intégration de l'ADN
- C- Est à l'origine d'une transmission plus faible du virus chez l'Homme
- D- Représente un obstacle au développement du vaccin contre le VIH
- E- Est due à la forte réplication du virus du VIH

QCM 55-Les infections opportunistes les plus fréquentes chez le sujet infecté par le VIH sont :

- A- La toxoplasmose cérébrale
- B- La cryptococcose neuroméningée
- C- La pneumocystose pulmonaire
- D- La leucoencéphalite multifocale progressive
- E- La leishmaniose viscérale

QCM 56-Au cours d'une Insuffisance Rénale Aiguë fonctionnelle, quelle(s) anomalie(s) biologique(s) retrouve(nt)-t-on habituellement ?

- A- Na⁺ urinaire (natriurèse) > 100 mmol/L
- B- Une Fraction d'Excrétion du sodium < 1 %
- C- Un rapport Na⁺/K⁺ urinaire < 1
- D- Rapport Urée urinaire/Urée plasmatique > 10
- E- Une Fraction d'Excrétion de l'Urée > 70 %

QCM 57- Au cours d'une insuffisance rénale dans quelles circonstances peut on trouver [Urée] plasmatique élevée:

- A- IRA fonctionnelle
- B- En cas de traitement par corticoïdes
- C- En cas d'hyponatrémie
- D- En cas de saignement digestif
- E- En cas de rhabdomyolyse

QCM 58-L'insuffisance rénale aiguë (IRA) secondaire aux anti-inflammatoires non stéroïdiens peut être due à :

- A- Une nécrose tubulaire aiguë
- B- Une insuffisance rénale aiguë hémodynamique
- C- Une insuffisance rénale aiguë obstructive
- D- Une néphrite interstitielle aiguë immuno-allergique

E- Des lésions glomérulaires minimes

QCM 59-La corticothérapie est indiquée au cours des insuffisances rénales aiguës organiques secondaires à

- A- Une glomérulonéphrite aiguë post infectieuse
- B- Une néphropathie interstitielle aiguë immuno-allergique
- C- Une nécrose tubulaire aiguë
- D- Une vascularite à ANCA
- E- Une néphropathie lupique

QCM 60- les principales caractéristiques du syndrome malin des neuroleptiques sont:

- A- Rigidité musculaire
- B- Hyperthermie
- C- Troubles de la conscience
- D- Myosis serré bilatéral
- E- CPK élevées

QCM 61- concernant le traitement antidotique des intoxications aux benzodiazépines, le flumazénil est :

- A. Un antagoniste compétitif des récepteurs GABA-Aergique
- B. Administré par voie orale
- C. Indiqué en cas d'intoxication mixte antidépresseurs tricycliques + benzodiazépines
- D. Susceptible de déclencher des convulsions
- E. Indiqué en cas de coma benzodiazépiné isolé

QCM 62-Quels signes appartiennent au syndrome nicotinique ?

- A- Mydriase
- B- Crampes et paralysie musculaire
- C- Fasciculations musculaires
- D- Tachycardie
- E- Hypotension artérielle

QCM 63- Quelles sont les complications possibles d'une intoxication aux organophosphorés ?

- A- Pancréatite aiguë
- B- Syndrome intermédiaire (paralysie retardée)
- C- Œdème pulmonaire lésionnel
- D- Neuropathie périphérique retardée
- E- Syndrome pyramidal

QCM 64- Quels mécanismes expliquent la toxicité du CO ?

- A- Affinité du CO pour Hb 200–250 fois supérieure à celle de l'O₂
- B- Formation de carboxyhémoglobine
- C- Augmente la libération d'O₂ aux tissus
- D. Fixation sur myoglobine et cytochromes
- E. Provoque une hypoxie histotoxique

QCM 65- Les paramètres mesurés dans les urines de 24 heures pour le bilan lithiasique de 1ère intention sont :

- A. Calcium
- B. Créatinine
- C. pH urinaire
- D. Urée
- E. Acide urique

QCM 66- Concernant les lithiases oxalocalciques, laquelle/lesquelles des propositions est(sont) vraie(s) ? :

- A. Elles sont les plus fréquentes, représentant environ 70% des calculs urinaires.
- B. Elles sont toujours radio-transparentes
- C. Elles incluent le type Whewellite (monohydraté) et Weddellite (dihydraté)
- D. Elles sont liées à une hyperuricosurie.
- E. Leur densité au scanner est généralement faible (< 500 UH).

QCM 67- Parmi les lithiases urinaires suivantes, lesquelles sont radiotransparentes à l'imagerie ?

- A. Lithiases uriques
- B. Phosphates ammoniaco-magnésiens
- C. Phosphates de calcium
- D. Oxalate de calcium
- E. Lithiases xanthiques

QCM 68- Parmi les caractéristiques de l'atteinte articulaire de la polyarthrite rhumatoïde, on retient :

- A. Atteinte bilatérale et symétrique des petites articulations.
- B. Atteinte déformante.
- C. Atteinte migratrice.
- D. Atteinte non érosive.
- E. Atteinte exclusive des petites articulations.

QCM 69- Concernant l'épidémiologie de la polyarthrite rhumatoïde, quelle (s) affirmation (s) est (sont) juste (s) ?

- A. C'est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent.
- B. Elle débute habituellement entre 40 et 60 ans.
- C. Elle ne s'observe pas après 65 ans.
- D. Des formes juvéniles peuvent apparaître avant 16 ans.
- E. Elle ne peut pas survenir chez l'homme.

QCM 70- Concernant la réaction immunitaire dans la PR, quelle (s) affirmation (s) est (sont) juste (s) ?

- A. Les lymphocytes Th17 produisent l'interféron gamma.
- B. L'activation des lymphocytes T CD4+ se fait via les cellules présentatrices d'antigène exprimant HLA-DR4/DR1.
- C. L'IL-17 est produite par les lymphocytes Th17.
- D. Le rôle des lymphocytes B est négligeable.
- E. Les lymphocytes Th1 produisent l'interleukine 2 (IL-2) et l'interféron gamma.

QCM 71-Concernant le facteur rhumatoïde, quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) ?

- A. C'est une immunoglobuline de classe IgG dirigée contre des IgM.
- B. Le test de Waaler-Rose repose sur l'agglutination de globules rouges de mouton sensibilisés par un sérum de lapin anti-globules rouges de mouton.
- C. Le test au latex utilise des particules de polystyrène recouvertes d'IgG humaines.
- D. Les tests modernes comme la néphélométrie et l'ELISA ont remplacé le test de Waaler-Rose et au Latex dans la pratique courante.
- E. Le test de Waaler-Rose est plus sensible et plus spécifique que la néphélométrie et l'ELISA.

QCM 72-Quelles sont les anomalies qu'on peut rencontrer sur les radiographies d'une main rhumatoïde :

- A- Erosions et géodes osseuses.
- B- Calcification du ligament triangulaire du carpe.
- C- Déminéralisation en bandes.
- D- Ostéophytes des interphalangiennes distales.
- E- Carpite fusionnante.

QCM 73-Concernant les échelles unidimensionnelles :

- A- Sont des échelles globales.
- B- Comportent l'échelle visuelle analogue (EVA), l'échelle numérique (EN) et l'échelle verbale simple (EVS).
- C- Sont utilisables quel que soit l'âge.
- D- Permettent d'évaluer la réponse au traitement antalgique.
- E- Sont simples.

QCM 74-L'échelle numérique

- A- Est une échelle unidimensionnelle
- B- Est une échelle multidimensionnelle.
- C- Sa valeur varie de 0 à 10.
- D- Une valeur maximale signifie pas de douleur.
- E- Utilise une règle.

QCM 75-Choisissez les antalgiques de niveau 2 :

- A- Néfopam.
- B- Dérivés salicylés.
- C- Fentanyl.
- D- Codéine.

E- Propofol.

QCM 76-L'antidote de la morphine :

- A- Anexate.
- B- Kétamine.
- C- Protamine.
- D- N-acétylcystéine.
- E- Naloxone.

QCM 77-Le purpura vasculaire est :

- A- Nécrotique
- B- Diffus
- C- Extensif
- D- Associé à un syndrome hémorragique
- E- Palpable

QCM 78-Quelles sont parmi les propositions suivantes les critères de gravité d'un purpura

- A- La présence d'une oligoanurie associée
- B- Son aspect en carte géographique
- C- Sa survenue chez un patient sous sintrom
- D- La présence d'une fièvre
- E- Thrombopénie $< 50\,000$

QCM 79-La thrombopénie immunologique primaire

- A-Est le diagnostic le plus fréquent chez la femme jeune
- B- Impose en pratique la recherche des anticorps anti-plaquettes
- C- Est caractérisé par une moelle riche à la ponction sternale
- D- Nécessite les immunoglobulines en traitement de 1ère ligne
- E- Est souvent associée à une bi ou pancytopénie

QCM 80- le purpura rhumatoïde

- A- Est caractérisé par une vascularite avec dépôt d'IgA
- B- Est caractérisé par un purpura diffus
- C- Est très fréquent chez le sujet âgé
- D- Peut se compliquer de néphropathie glomérulaire
- E- Donne des lésions cutanées qui peuvent évoluer par poussées

QCM 81-Le pouvoir tampon d'une solution est d'autant plus grand que:

- A. Le trouble acide base est ancien
- B. Le pKa est faible

- C. Le stock du tampon est important
- D. Le stock acide est important
- E. Le pKa est proche du pH du milieu

QCM 82-Le système tampon bicarbonate-acide carbonique :

- A- est efficace en cas d'alcalose
- B- a une masse constante
- C- est peu efficace en cas d'acidose
- D- est soumis à un double contrôle viscéral
- E-a une activité importante dans les compartiments intracellulaires

QCM 83-Les chémorécepteurs périphériques :

- A. sont insensibles aux CO₂
- B. ont une action lente
- C. sont sensibles à la PO₂
- D. inhibent les muscles ventilatoires
- E. sont stimulés par les ions H⁺

QCM 84-Le rein intervient dans l'équilibre acido-basique :

- A. au bout de quelques secondes
- B. en sécrétant les acides fixes
- C. en éliminant une urine de pH variable
- D. en excréant l'ammonium
- E. en sécrétant les acides volatils

QCM 85-L'excrétion tubulaire de l'ammonium est favorisée par :

- A. l'alcalose
- B. l'acidose
- C. l'aldostérone
- D. la déplétion en potassium
- E. le traitement par des corticoïdes

QCM 86-Les éléments suivants sont en faveur d'une sécrétion inappropriée d'ADH:

- A/Une osmolalité urinaire > 100mOsm / kg
- B/Une concentration de sodium urinaire ≥ 40 mmol / l
- C/ Un volume de liquide extracellulaire diminué
- D/Une hyperuricémie
- E/Une hypoosmolalité plasmatique

QCM 87-Les causes suivantes peuvent être responsables d'une sécrétion inappropriée d'ADH

- A/Une tumeur cérébrale
- B/Un hématome sous dural
- C/Un traitement par Carbamazépine
- D/Un traitement par le lithium
- E/Une tuberculose pulmonaire

QCM 88-Dans lesquelles des situations suivantes peut-on observer une hyponatrémie hypertonique?

- A. myélome multiple
- B. Hypertriglycéridémie sévère
- C. Diurèse osmotique
- D. Hyperglycémie majeure
- E. Intoxication au méthanol

QCM 89-Les étiologies de diabète insipide néphrogénique

- A/ Hypocalcémie
- B/ Hypercalcémie
- C/ Intoxication par le lithium
- D/ Tumeur hypothalamo-hypophysaire
- E/ Hypokaliémie

QCM 90- Une hypokaliémie de transfert est secondaire à :

- A-Un traitement par insuline semi lente
- B- Unethyrotoxicose
- C- La prise de caféine
- D- La prise de théophylline
- E- La prise de bêta bloqueurs

QCM 91- Devant une hypokaliémie associée à une alcalose métabolique on évoque :

- A- La prise du Modamide
- B- Des diarrhées
- C- La prise de diurétique thiazidiques
- D- La prise d'acétazolamide (Diamox*)
- E- Un hyperaldostérionisme primaire

QCM 92- Une hyperkaliémie associée à une hypocalcémie peut être observée en cas de :

- A- Un syndrome de lyse tumoral
- B- Un myélome multiple
- C- Une insuffisance surrénalienne aiguë
- D- Une insuffisance rénale chronique stade 5
- E- Une rhabdomyolyse

QCM 93- Une hyperkaliémie peut être secondaire à la prise de :

- A-Bactrim*
- B- Corticoïdes
- C- Héparine
- D- Piroxicam
- E- Salbutamol

QCM 94- Les éléments suivants influencent directement l'immunogénicité d'un vaccin :

- A. La voie d'administration
- B. L'ajout d'un adjuvant
- C. La nature chimique de l'antigène vaccinal
- D. L'intervalle entre les doses
- E. L'âge gestationnel du nourrisson à la naissance

QCM 95 - Les adjuvants des vaccins :

- A. sont systématiquement utilisés avec les vaccins vivants atténués
- B. augmentent la réponse immunitaire vis-à-vis de l'antigène
- C. favorisent la libération prolongée de l'antigène
- D. sont souvent des sels d'aluminium
- E. peuvent réduire le nombre de doses nécessaires à l'immunisation

QCM 96- Les manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) :

- A. peuvent survenir même sans lien prouvé avec le vaccin
- B. sont graves et nécessitent l'arrêt du schéma vaccinal
- C. sont souvent inévitables
- D. peuvent être liées à une erreur de manipulation du vaccin
- E. peuvent se présenter comme des états fébriles bénins

QCM 97 - A propos des effets secondaires suivants du vaccin antioquelucheux entier :

- A. Le syndrome du cri persistant est une réaction rare mais bien décrite
- B. Une fièvre dans les 48 heures est une réaction courante
- C. L'état de choc post-vaccinal est une urgence exceptionnelle et bénigne
- D. Une encéphalopathie après vaccination impose l'arrêt de cette valence
- E. Les effets indésirables graves justifient l'arrêt de toute dose vaccinale future

QCM 98– Les vaccins qui doivent être administrés au 2ème mois de vie selon le calendrier vaccinal tunisien sont :

- A. 1ère dose du vaccin anti-hépatite B combiné à d'autres vaccins
- B. 1ère dose de vaccin anti-pneumococcique conjugué
- C. 1ère dose du vaccin anti-polio injectable
- D. 1ère dose de vaccin anti-polio oral
- E. 1ère dose du vaccin pentavalent

I- Partie II : CCQCM

Cette partie comprend cas cliniques. Les réponses doivent être inscrites sur la grille réservée aux CCQCM

Cas clinique QCM 1

Une patiente âgée de 42 ans, sans antécédents pathologiques notables, vous consulte pour une fièvre évoluant depuis 3 jours, asthénie, et des lésions d'érythème noueux depuis 1 jour. Elle rapporte par ailleurs une toux sèche d'apparition récente. A l'examen, la température était de 38°C, la TA 120/80 mmHg, la palpation du cou trouve des adénopathies cervicales bilatérales fermes et indolores.

QCM 1-Devant ce tableau, les diagnostics possibles sont les suivants :

- A-Tuberculose
- B- Sarcoidose
- C- Syphilis
- D- Brucellose
- E- Leucémie lymphoïde chronique

QCM 2-Une radiographie du thorax faite chez cette patiente montre des opacités hilaires bilatérales, vous évoquez

- A-Tuberculose
- B- Sarcoidose
- C- Syphilis
- D- Brucellose
- E- Leucémie lymphoïde chronique

QCM 3-Parmi les propositions suivantes quels examens complémentaires vous demandez

- A-Sérologie wright
- B- Immunophénotypage lymphocytaire
- C- Frottis sanguin
- D- IDR
- E- TDM thoracique

Cas clinique QCM 2

Mr A.Z âgé de 70 ans, ramené aux urgences par sa famille pour asthénie, vertiges, myalgies. Il a comme antécédents : une hypercholestérolémie traitée par statine (atorvastatine 10mg/j), un diabète de type 2 sous glimépiride 2mg, des troubles du rythme cardiaque sous Amiodarone, un syndrome dépressif sous anti-dépresseurs, une anémie traitée par Fer avec Gastrite à HP sous IPP. A l'examen : la peau est infiltrée, jaunâtre, sèche, froide, la pilosité est raréfiée, oedème palpébral, apyrétique, TA= 11/6 cmHg, rythme régulier FC: 60 batt/min, eupnéique, thyroïde non palpable, les ROT diminués, discrets oedèmes des membres inférieurs bilatéraux

ECG: Rythme régulier Sinusal, Fréquence cardiaque à 60, microvoltage, troubles de la repolarisation.

QCM4- Le diagnostic d'hypothyroïdie est suspecté devant :

- A- Le syndrome dépressif
- B- La somnolence
- C- Les myalgies
- D- L'anémie par carence martiale
- E- Le microvoltage à l'ECG

QCM5- Une exploration biologique doit être demandée à la recherche de:

- A- Une hypernatrémie
- B- Une anémie avec microcytose
- C- Une hypokaliémie avec kaliurèse augmentée
- D- Des CPK élevées
- E- Une tendance à l'hypoglycémie

Le bilan a montré: TSH = 60 mUI/l, FT4 = 5 pmol/l, CPK= 1000UI, Hb= 9 g/l, Na+= 140mmol/l, K+= 4 mmol/l, Glycémie à jeun = 3,8 mmol/l, créatinémie = 150µmol/l, LDL-Cholestérol= 1,6g/l.

QCM6- La conduite à tenir immédiate est de :

- A- Augmenter la dose de statine
- B- Rechercher une insuffisance coronaire
- C- L-thyroxine 100 µg en IV
- D- Arrêter le glimépiride
- E- Réhydratation en IV

Cas clinique QCM 3

Patient âgé de 50 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, consulte pour syndrome anémique évoluant depuis 15 jours.

L'examen clinique note une pâleur cutanéomuqueuse, un ictère conjonctival et une splénomégalie à 3 cm du rebord costal. Le reste de l'examen est normal.

Hémogramme : GB: 6700/mm³, PNN 65%, Lym 30%

Hb: 8,5 g/dl (VGM:88), GR: 3.000.000/mm³, Rétic 6%

Plaquettes: 324.000/mm³.

QCM7 -Quels sont les examens à demander dans le cadre de l'exploration de cette anémie ?

- A. Bilirubine libre
- B. Electrophorèse des protéines plasmatiques (EPP)
- C. Myélogramme
- D. Haptoglobine
- E. LDH

En plus du bilan biologique que vous avez demandé, on a complété par :

Frottis sanguin : sans anomalies
Test de Coombs Direct (TCD) : positif à Ig G

QCM 8-Quel est le diagnostic que vous avez retenu ?

- A. Anémie Hémolytique Auto Immune (AHAI)
- B. Anémie Hémolytique Allo Immune
- C. Anémie Hémolytique immuno allergique
- D. Anémie Hémolytique d'origine corpusculaire
- E. Anémie Hémolytique d'origine mécanique

QCM 9-Quel est le bilan biologique à visée étiologique à demander dans le cadre de l'exploration de cette anémie?

- A. Sérologies de l'Hépatite B et C
- B. Electrophorèse des protéines plasmatiques (EPP)
- C. Scanner thoraco-abdomino pelvien
- D. Biopsie ostéo médullaire
- E. AAN

QCM 10-Quel traitement proposez-vous ?

- A. Splénectomie
- B. Transfusion par 2 culots globulaires
- C. Immunoglobulines par voie IV
- D. Prednisone (Cortancyl®) : 1 à 2 mg/kg/j pendant 3 semaines puis une dégression sur 3 semaines
- E. Prednisone (Cortancyl®) : 1 à 2 mg/kg/j pendant 3 semaines puis une dégression sur 3 à 4 mois

Cas clinique QCM 4

Monsieur M, âgé de 55 ans, aux antécédents de diabète et de goutte, consulte aux urgences pour une impotence fonctionnelle du genou droit. A l'anamnèse, vous apprenez que les symptômes évoluent depuis dix jours. Il a pris de l'amoxicilline de son propre chef pendant 3 jours. Le patient vous signale aussi qu'il a eu il y a 15 jours une injection de corticoïdes au niveau de ce même genou pour une gonarthrose débutante. L'examen aux urgences trouve : une température à 37.6°C, une impossibilité de marcher, un genou droit globalement tuméfié chaud à la palpation. La moindre mobilisation passive est extrêmement douloureuse. Vous suspectez une arthrite septique du genou.

QCM 11- Quel(s) élément(s) peut(vent) expliquer l'absence de fièvre chez ce patient :

- A. L'injection de corticoïdes dans le genou
- B. L'antécédent de goutte
- C. Le diabète
- D. L'automédication par amoxicilline
- E. Il s'agit d'une forme débutante

QCM 12- Les 2 diagnostics différentiels à évoquer chez ce patient sont :

- A. Une poussée de gonarthrose
- B. Une poussée polyarthrite rhumatoïde
- C. Une crise de goutte
- D. Une lombosciatique tronquée
- E. Une arthropathie diabétique

Vous trouvez effectivement un épanchement du genou et vous décidez alors de réaliser une ponction du liquide articulaire afin de confirmer le diagnostic d'arthrite septique. Les résultats de l'analyse du liquide ponctionné sont les suivants :

-aspect : 60ml de liquide trouble

-examen direct à la coloration de Gram : présence de cocci gram positif en chainettes

-examen cytologique : leucocytes= 45000 avec 100% de type polynucléaires altérés, hématies=0, absence de microcristaux

-examen biochimique : Glucose 1.2mmol/l, Protides=98g/l

QCM 13- Quelle(s) est (sont) l'(les) affirmation(s) exacte(s) :

- A. Le taux de glucose est élevé
- B. Le taux de protides est élevé
- C. L'aspect trouble confirme le diagnostic d'arthrite septique
- D. Le caractère altéré des polynucléaires est en faveur du diagnostic d'arthrite septique
- E. La présence de cocci gram positif confirme le diagnostic d'arthrite septique

QCM 14- Le diagnostic d'arthrite septique du genou est retenu. Quelle bactérie est-elle le plus probablement responsable de cette arthrite septique ?

- A. Streptococcus pneumoniae

- B. Echerchia coli
- C. Staphylococcus aureus
- D. Nisseriagonorrhoeae
- E. Mycobacteriumtuberculosis

Cas clinique QCM 5 :

Patient âgé de 54 ans, sans antécédents pathologiques notables, piéton ayant été heurté par une voiture, est emmené aux urgences pour un traumatisme ouvert de la jambe droite.

L'examen trouve une déformation de la jambe droite avec une plaie déchiquetée et contuse faisant 10 centimètres. Le pouls est présent et l'examen neurologique est sans anomalies.

La radiographie de la jambe montre une fracture comminutive du tiers moyen des deux os de la jambe.

QCM 15-Quels sont les gestes que vous devez pratiquer aux urgences ?

- A. Un parage économe de la plaie
- B. Administration d'antibiotiques par voie orale
- C. Vaccination antitétanique
- D. Lavage de la plaie et pansement stérile
- E. Administration de la première dose d'énoxaparine

Après le parage, la plaie ne peut pas être suturée et il persiste une perte de substance cutanée de 3*7 centimètres.

QCM 16- Le traitement de cette fracture peut se faire moyennant :

- A. Un enclouage centromédullaire
- B. Une traction trans-condylienne
- C. Une plaque vissée
- D. Un fixateur externe
- E. Une attelle cruro-pédieuse jusqu'à la cicatrisation cutanée

QCM 17-La prise en charge de la perte de substance cutanée consiste à :

- A. Un lambeau de couverture d'emblée si l'os est exposé
- B. Une greffe de peau mince d'emblée
- C. Une amputation vu le caractère comminutif de la fracture
- D. La cicatrisation dirigée peut être une alternative si l'os n'est pas exposé
- E. La couverture par un lambeau n'est autorisée qu'après la consolidation osseuse

QCM 18-Ce patient est exposé aux complications tardives suivantes :

- A. Infection précoce
- B. Ostéite chronique
- C. Pseudarthrose septique
- D. Syndrome de loges
- E. Embolie pulmonaire

Cas clinique QCM 6

Une patiente âgée de 35 ans sans antécédents pathologiques personnels et familiaux notables présente une insuffisance rénale découverte devant une hématurie macroscopique installée depuis 03 jours. La patiente se plaignait de polyarthralgies depuis 1 an. Elle rapporte un épisode d'angine qui remonte à 02 mois.

Examen clinique : PA : 160/90 mmHg, œdème au niveau des deux membres inférieurs bilatéral, symétrique et garde le godet, bandelettes urinaires : Protéine : ++, Hématurie : +++

Biologie : créatinine sérique : 150 $\mu\text{mol/l}$, protidémie : 70g/l, albuminémie : 40g/l, protéinurie : 2g/24h, CRP : 40mg/l, ECU : H : 600/mm³, L : 3/mm³, culture négative.

QCM 19- L'hématurie présentée par la patiente est d'origine glomérulaire devant les arguments suivants :

- A. Son caractère macroscopique
- B. La présence d'une pression artérielle : 160/90 mmHg
- C. Son association à une protéinurie à 2g/24h
- D. Les antécédents de polyarthralgies
- E. Son association à une insuffisance rénale

QCM 20- Les examens complémentaires à demander chez cette patiente pour étayer le diagnostic étiologique de cette hématurie sont :

- A. Dosage des fractions C3 et C4 du complément sérique
- B. Recherche des anticorps anti nucléaires
- C. Uroscanner
- D. Cystoscopie
- E. Biopsie rénale

QCM 21- Les étiologies possibles de l'hématurie chez cette patiente sont :

- A. Une GNA post infectieuse
- B. Un syndrome de Good Pasture
- C. Une néphropathie lupique
- D. Une Vascularite à ANCA
- E. Une cryoglobulinémie

Cas clinique QCM 7

Un homme de 45 ans victime d'un accident de la voie publique, présente une fracture spiroïde des deux os de la jambe ouverte type II de Cauchoix.

QCM 22- Une fracture ouverte de jambe Cauchoix II comporte :

- A. une perte de substance cutanée dont la suture est impossible
- B. une plaie suturable facilement sans tension

- C. doit être suturer aux urgences pour prévenir le risque infectieux
- D. une lésion cutanée à risque de nécrose secondaire
- E. une plaie à berge contuse

QCM 23-La prise en charge initiale en urgence de ce patient consiste à :

- A. deux voies d'abord périphérique et vérification des constantes hémodynamiques
- B. la sérothérapie anti tétanique est administrée selon le profil vaccinal du patient.
- C. parage et lavage de la plaie
- D. pansement stérile.
- E. une antibiothérapie synergique par voie générale à large spectre.

L'examen effectué aux urgences relève une impossibilité de la flexion dorsale du pied et des orteils.

QCM 24-La complication immédiate suspectée en premier lieu devant ces constatations cliniques est :

- A. le syndrome des loges
- B. la lésion du nerf sciatique poplitée externe
- C. la thrombophlébite
- D. l'atteinte de l'artère tibiale postérieure
- E. la section du tendon du muscle tibial antérieur

QCM 25-Les éléments de mauvais pronostic chez ce patient sont :

- A. l'âge jeune
- B. la fracture comminutive
- C. le trait spiroïde
- D. l'ouverture cutanée type II de Cauchoux
- E. l'atteinte simultanée des deux os de la jambe

Cas clinique QCM 8

Une femme de 62 ans consulte pour asthénie, constipation et douleurs osseuses diffuses depuis plusieurs semaines.

À l'examen : TA = 135/80 mmHg, FC = 92/min, sécheresse des muqueuses, sensibilité osseuse diffuse.

Examens complémentaires :

- Calcémie totale : 3,2 mmol/L
- Albumine : 38g/L
- Phosphorémie : 0,6 mmol/L
- Créatinine : 120 µmol/L
- PTH intacte : 180 pg/mL
- Électrophorèse des protéines sériques : pas de pic monoclonal
- Radiographie du rachis lombaire : lésions ostéolytiques diffuses

QCM 26- les anomalies biologiques mises en évidence chez ce patient sont

- A. Hypophosphorémie
- B. Hypercalcémie
- C. Insuffisance rénale
- D. Hyperparathormonémie
- E. Hypoalbuminémie

QCM 27- la/(les) étiologie(s) plus probable(s) devant ce tableau est /sont:

- A. Hyperparathyroïdie primitive
- B. Hypercalcémie paranéoplasique (sécrétion de PTHrP)
- C. Sarcoïdose
- D. Myélome multiple
- E. Hypercalcémie iatrogène (vitamine D, thiazidiques)

QCM 28- les mesures thérapeutiques initiales à instaurer en urgence :

- A. Perfusion de sérum physiologique abondant (réhydratation)
- B. Bisphosphonates IV
- C. Restriction hydrique stricte
- D. Corticothérapie systématique d'emblée
- E. Administration de calcitonine pour son effet prolongé

Cas clinique QCM 9

Un nouveau-né âgé de 15 jours est ramené par ses parents aux urgences pédiatriques pour ictère cutanéomuqueux constaté depuis J5 de vie. A l'interrogatoire, les urines sont foncées et les selles décolorées.

QCM 29- Les diagnostics à évoquer devant cet ictère sont :

- A- Tumeur de la tête du pancréas
- B- Syndrome d'Alagille
- C- Atrésie des voies biliaires
- D- Déficit en alpha 1 antitrypsine
- E- Maladie de Wilson

QCM 30- L'examen d'imagerie, de première intention, que vous demandez sera:

- A- Abdomen sans préparation
- B- Echographie abdominale
- C- Echographie cardiaque
- D- Cholangiographie transhépatique
- E- Radiographie de thorax

QCM 31- Le bilan sanguin montre ces anomalies:

- A- Hyperbilirubinémie à prédominance libre
- B- Hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée
- C- ASAT et des ALAT élevées
- D- Taux de prothrombine bas
- E- Phosphatases alcalines basses

Cas clinique QCM 10

Patiente âgée de 25 ans aux antécédents de rhumatisme articulaire aigu présente de façon brutale depuis deux jours des lésions purpuriques au niveau des membres inférieurs, des douleurs articulaires et une diminution de la diurèse. A l'examen clinique : température : 38°, PA : 170/90 mmHg, œdème des membres inférieurs et du visage. Bandelettes urinaires : Protéinurie : ++ et hématurie : +++ . Biologie : créatinine sérique : 200 μ mol/l, NFS : GB : 2500/mm³, HB : 8g/dl, plaquettes : 100000/mm³, protéinurie : 2,5g/24h albuminémie : 38g/l, protidémie : 70g/l, et complément sérique bas.

QCM 32- L'hématurie présentée par la patiente est d'origine glomérulaire car elle est associée à :

- A- Une protéinurie
- B- Des œdèmes des membres inférieurs
- C- Une hypertension artérielle
- D- Une oligurie
- E- Une insuffisance rénale

QCM 33- Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente sont :

- A- Une endocardite infectieuse
- B- Une néphropathie lupique
- C- Une vascularite à ANCA
- D- Un purpura rhumatoïde
- E- Une thrombose des veines rénales

QCM 34- Les examens complémentaires nécessaires chez cette patiente sont :

- A- Un scanner thoraco-abdomino-pelvien
- B- Des hémocultures
- C- La recherche des anticorps anti nucléaires
- D- La recherche des anticorps anti-cytoplasme des PNN
- E- Une échographie doppler des veines rénales

QCM 35- Une ponction biopsie rénale est indiquée chez patiente car l'hématurie s'associe à :

- A- Une protéinurie à 2,5g/24h
- B- Une pancytopénie
- C- Des lésions purpuriques
- D- Une fièvre
- E- Des œdèmes des membres inférieurs

Cas clinique QCM 11

Le jeune AH , piéton âgé de 23 ans, s'est fait renverser par une moto « Forza » occasionnant un traumatisme crânien. A l'arrivée de l'équipe de SMUR, le patient était inconscient : n'ouvrait pas les yeux à la stimulation douloureuse, émettait des sons incompréhensibles avec réaction de retrait à la douleur. Pupilles en anisocorie. Sa PA= 100/62mmHg FC=98B/min et SpO2= 97% à l'AA.

QCM 36-quelle est la valeur du score de Glasgow chez ce patient ?

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 7
- E. 8

QCM 37-quelle CAT à initier chez ce patient ?

- A. Induction anesthésique
- B. Intubation orotrachéale
- C. HTAthérapie
- D. Osmothérapie
- E. Hypercapnie permissive

A l'arrivée à l'hôpital, un scanner cérébral et du rachis cervical ont montré l'aspect suivant :



QCM 38. les anomalies à décrire sont :

- A. Hématome sous dural aiguë
- B. Hématome extradural
- C. Effacement des sillons sous corticaux
- D. Déviation de la ligne médiane
- E. Fracture occipitale

QCM 39. l'anomalie décrite sur le scanner:

- A. Est secondaire à un Saignement artériel entre la dure-mère et l'os
- B. Est secondaire à une rupture veineuse lentement progressive.
- C. Nécessite un traitement chirurgical
- D. Entraîne une augmentation de la pression intracrânienne selon la loi de Monroe-Kellie
- E. Est sans gravité clinique

Après les mesures thérapeutiques prises ,uneneuroréanimation est poursuivie. Le bilan trouve : Hb=7.4 plq=78000 TP=74% Na+=143 paCO2=32 mmHggly=2.5mmol/l

QCM 40. les ACSOS sur ce bilan :

- A. Sont au nombre de 3
- B. L'hypocapnie est nécessaire pour diminuer la PIC
- C. Le seuil de plaquettes est 50000
- D. La glycémie n'est pas une ACSOS
- E. Il faut transfuser le patient pour un objectif d'Hb à 9-10g/dl

Cas clinique QCM 12

Une patiente âgée de 75 ans suivie pour une insuffisance cardiaque traitée par furosémide, digitaline et beta bloqueurs et pour une ostéoporose traitée par calcium et vitamine D présente pour une asthénie, une faiblesse musculaire, des palpitations et une constipation installée depuis une semaine. A l'examen clinique : PA : 100/50 mmHg, pli cutané persistant, auscultation cardio-pulmonaire normale et un tympanisme abdominal. Biologie : créatinine sérique : 50 μ mol/l, natrémie : 135mmol/l, Kaliémie : 2,4mmol/l, chlorémie : 85mmol/l, GDS artériel : PH : 7,50, bicarbonatémie : 30mmol/l.

QCM 41. Les critères de gravité de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. L'antécédent d'une insuffisance cardiaque
- B. La prise de digitaline
- C. La présence d'une alcalose métabolique
- D. La kaliémie à 2,4 mmol/l
- E. L'âge à 75 ans

QCM 42- Les signes électrocardiographiques à rechercher chez cette patiente sont :

- F. Une arythmie par fibrillation auriculaire
- G. Des extra systoles supra ventriculaires
- H. La disparition de l'onde P
- I. L'onde U
- J. Le sous décalage du segment PQ

QCM 43- Les causes possibles de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- K. Prise du furosémide
- L. Des vomissements
- M. Intoxication aux digitaliques
- N. Prise de bêta bloqueur
- O. La prise de calcium au long cours

QCM 44-Les examens complémentaires de première intention à demander à la recherche d'une étiologie de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. Kaliurèse de 24 heures
- B. Aldostéronémie
- C. Activité rénine plasmatique
- D. Chlore urinaire
- E. Echographie doppler des artères rénales

Cas clinique QCM 13

Un patient âgé de 25 ans consulte pour fièvre et splénomégalie

QCM 45-Les éléments à rechercher à l'interrogatoire sont

- A. Durée d'évolution
- B. Mode d'installation de la fièvre
- C. Notion de prise de paracétamol
- D. Notion de consommation d'alcool
- E. Notion de consommation de lait non pasteurisé

Le patient vous informe que la fièvre a débuté depuis 4 jours, 7 jours après son retour d'un voyage au Cameroun

QCM 46-Le premier diagnostic à évoquer à ce stade est

- A. Paludisme
- B. Rickettsiose
- C. Brucellose
- D. Infection CMV
- E. Endocardite infectieuse

Les examens microbiologiques effectués ont permis d'éliminer ce diagnostic

QCM 47-A ce stade quels examens complémentaires demandez vous

- A. Radio thorax
- B. Sérologie CMV
- C. Sérologie Wright
- D. Anticorps antinucléaire
- E. Hémoculture

Les examens demandés sont revenus négatifs. Par ailleurs le patient est en bon état général, sa CRP : 5mg/L. les GB : 3200/mm³ avec présence de lymphocytes activés au frottis sanguin.

QCM 48-Vous retenez le diagnostic de

- A. Infection CMV
- B. Rickettsiose
- C. Brucellose
- D. Tuberculose
- E. Endocardite infectieuse

Cas clinique 14

Monsieur XY vient vous consulter à la suite de la découverte d'une sérologie VIH positive lors d'un don de sang. Il avoue une toxicomanie par voie intraveineuse depuis plusieurs années.

QCM 49-Pour confirmer l'infection par le VIH vous demandez les examens suivants :

- A. Western blot
- B. ELISA 4^{ème} génération
- C. PCR VIH
- D. Taux de CD4
- E. Antigénémie P24

QCM 50-Le bilan initial à réaliser chez ce patient après la confirmation du diagnostic comprend :

- A. Une sérologie syphilis
- B. Une sérologie toxoplasmose
- C. Un taux de CD4
- D. Bilan lipidique, hépatique et rénal
- E. Une sérologie du virus HSV et gonocoque

Le bilan a été réalisé et vous avez prescrit une trithérapie chez ce patient avec un RDV de contrôle à 1 mois. Le patient était perdu de vue. Une année plus tard il consulte les urgences pour une altération de l'état général accompagnée de fièvre et diarrhées, le taux de CD4 est à 100/mm³.

QCM 51- Les diagnostics à évoquer chez ce patient sont :

- A. Une cryptosporidiose
- B. Une colite à CMV
- C. Une salmonellose
- D. Une leishmaniose viscérale
- E. Un sarcome de kaposi

Une endoscopie digestive a été réalisée et a montré une muqueuse colique inflammatoire et ulcérée avec la biopsie des cellules à inclusions virales intranucléaires en œil de hibou

QCM 52-Le diagnostic à retenir chez ce patient est

- A. Une cryptosporidiose
- B. Une colite à CMV
- C. Une salmonellose
- D. Une leishmaniose viscérale
- E. Un sarcome de kaposi

Cas clinique QCM 15

Patient âgé de 70 ans qui consulte pour syndrome anémique évoluant depuis 2 mois.

A l'examen on a objectivé des multiples adénopathies bilatérales et symétriques sous mandibulaires, sus claviculaires et axillaires (3 à 4 cm) avec une splénomégalie à 6cm du rebord costal.

NFS: GB=115 000 (Lymphocytes: 70%), HB=8,2 g/dl (VGM : 85, TCMH: 25),
Réticulocyte : 80 000 PLQ=90 G/L

Frottis sanguin : Petites lymphocytes matures monomorphes, avec présence d'ombres de Gumprecht.

Le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique (LLC) a été confirmé.

QCM 53. Quel est l'examen qui a permis de confirmer ce diagnostic ?

- A- Myélogramme
- B- Biopsie ostéo-médullaire
- C- Biopsie ganglionnaire
- D- Immunophénotypage lymphocytaire
- E- Cytopenction ganglionnaire

QCM 54. Le diagnostic de LLC est confirmé lorsque le score de Matutes est à :

- A- 5
- B- 4
- C- 3
- D- 2
- E- 1

QCM 55- Quel est le stade de la maladie selon la classification de Binet ?

- A- Stade A
- B- Stade B
- C- Stade C
- D- Stade D
- E- Stade E

QCM 56- Que proposez-vous pour ce patient ?

- A- Abstention thérapeutique
- B- Surveillance clinique et biologique à la consultation
- C- Traitement à base d'immuno-chimiothérapie
- D- Traitement à base d'immunothérapie seul
- E- Traitement à base de corticothérapie seul

Cas clinique QCM 16

Une patiente âgée de 35 ans consulte pour oligurie

L'examen Clinique de la patiente a permis de retrouver une PA: 150/90 mmHg et des Œdèmes des membres inférieurs

A la bandelette urinaire: Hématies ++ P+++

Résultats des examens complémentaires :

- ECBU: H: 200/mm³, L: 2/mm³, culture: négative
- Protéinurie de 24heures: 2g/24h
- Créatinine plasmatique: 180 µmol/l (créatine habituelle à 80 µmol/L)
- NFS: Hb: 10g/dl, GB: 9000/mm³, plaquettes: 200000/mm³

Echographie rénale :2 reins de taille normale bien différenciés sans obstacle.

Il s'agit d'une insuffisance rénale aigue.

QCM 57-A ce stade on peut évoquer les diagnostics suivants :

- A- Une néphropathie interstitielle aigue
- B- Une néphropathie vasculaire aigue
- C- Une néphropathie glomérulaire aigue
- D- Une nécrose tubulaire aigue
- E- Une insuffisance rénale aigue fonctionnelle

QCM 58-Les arguments en faveur de l'origine de l'insuffisance rénale sont son association à :

- A- L'oligurie
- B- Les données de la bandelette urinaire
- C- Une anémie
- D- La pression artérielle à 150 /90 mmHg
- E- Des œdèmes des membres inférieurs

QCM 59-L'évolution était marquée par une aggravation des chiffres de créatinine passant à 250 puis à 500 µmol/L en quelques jours. L'étiologie peut correspondre alors à ;

- A- Une vascularite à ANCA
- B- Une néphropathie interstitielle aigue immuno-allergique
- C- Une amylose rénale
- D- Une hyalinose segmentaire et focale
- E- Une néphropathie lupique classe IV

QCM 60-Quels examens indispensables pour le diagnostic étiologique de cette insuffisance rénale aigue :

- A- Un angioscanner des artères rénales
- B- Une biopsie des glandes salivaires accessoires
- C- Une ponction biopsie rénale
- D- La recherche d'une éosinophilurie
- E- Un dosage des ANCA

Cas clinique QCM 17

Vous recevez aux urgences une patiente âgée de 20, sans antécédents, qui consulte pour une éruption cutanée. Il s'agit de lésions purpuriques diffuses, non infiltrées et non nécrotiques évoluant depuis 1 jour. Elle rapporte qu'elle a présenté ce matin une épistaxis bilatérale qui a cédé spontanément. A l'examen elle était apyrétique, avec des bulles hémorragiques endobuccales. Le reste de l'examen était sans particularités. Une NFS demandé a montré :

Hb= 10g/dl - VGM= 72fl- PLT= 2000- GB= 5600

Son score hémorragique était de 11

QCM 61-Concernant les critères de gravité de ce purpura vous retenez :

- A- L'âge
- B- Le caractère diffus
- C- Le taux d'hémoglobine
- D- Le score hémorragique
- E- Le taux des plaquettes

QCM 62-Le diagnostic de thrombopénie immunologique primaire est retenu chez cette patiente, votre conduite thérapeutique immédiate est la suivante

- A- Corticothérapie à 1mg/kg/j
- B- Immunoglobulines polyvalentes
- C- Association immunoglobulines polyvalentes avec corticothérapie à 1mg/kg/j
- D- Splenectomie
- E- Rituximab

QCM 63-Le mécanisme physiopathologique du purpura dans ce contexte est

- A- Une thrombopénie périphérique par excès de destruction
- B- Une thrombopénie centrale
- C- Une thrombopénie périphérique par excès de consommation
- D- Une thrombopénie périphérique par anomalies de la répartition
- E- Une thrombopénie périphérique par hémodilution

Cas clinique QCM 18

Une patiente âgée de 32 ans, sans antécédent cardiovasculaire connu, est admise aux urgences pour dyspnée rapidement progressive, palpitations et malaise depuis 48h, survenus après un épisode fébrile 5 jours plus tôt.

À l'examen : TA = 82/50 mmHg, FC = 132 bpm, SpO₂ = 89 % sous 4 L/min d'O₂, Marbrures cutanées, extrémités froides, Turgescence jugulaire, crépitations bilatéraux aux bases, Diurèse < 0,3 ml/kg/h.

ECG : tachycardie sinusale avec troubles de repolarisation diffus

Biologie : Troponine très élevée, lactate = 5 mmol/L, NT-proBNP = 14200 pg/ml

Échocardiographie : ventricule gauche dilaté, hypokinétique global, FEVG = 20 %, pas de valvulopathie significative

Vous retenez le diagnostic d'une myocardite aigue fulminante.

QCM 64- Les éléments de ce cas en faveur d'un état de choc cardiogénique sont :

- A. Hypotension artérielle persistante
- B. Oligurie < 0,5 ml/kg/h
- C. Fièvre initiale
- D. Marbrures et extrémités froides
- E. FEVG > basse

QCM 65. La (les) examens complémentaires de confirmation diagnostique est (sont)

- A. IRM cardiaque
- B. Biopsie endomyocardique
- C. Coronarographie
- D. Dosage de la TSH
- E. sérologie virales

QCM 66 .Le traitement de cette patiente comporte :

- A. Oxygénothérapie avec objectif SpO₂ > 94 %
- B. Dobutamine
- C. Remplissage vasculaire
- D. Anticoagulation curative
- E. des diurétiques

QCM 67. Si la patiente reste instable malgré traitement optimal, les stratégies à envisager sont :

- A. ECMO veino-artérielle
- B. Assistance circulatoire par cœur artificiel
- C. Antibiothérapie probabiliste large spectre
- D. Contre-pulsion intra-aortique systématique
- E. Association de l'adrénaline

